

Avaliação do RN na **Sala de parto**

E a **hora de ouro**
passo a passo.

Apgar, Capurro e
**reanimação pela
diretriz 2026**



Material gratuito

ITH Educação · Nota 5 no MEC



• PARTE 1 · AVALIAR E CLASSIFICAR

Apgar e Capurro, sem confusão

O Apgar registra como o bebê respondeu nos primeiros minutos. O Capurro estima a idade gestacional quando ela não é conhecida. Nenhum dos dois decide se o RN precisa de ajuda para respirar.

Boletim de Apgar: 5 sinais, de 0 a 2 pontos cada

Sinal	0	1	2
Frequência cardíaca	Ausente	Menor que 100 bpm	100 bpm ou mais
Respiração	Ausente	Irregular	Regular ou choro forte
Tônus muscular	Flacidez total	Alguma flexão	Movimentos ativos
Irritabilidade reflexa	Sem resposta	Careta	Choro ou retirada
Cor	Cianose ou palidez	Corpo róseo, extremidades cianóticas	Tudo róseo

1

Quando

No 1º e no 5º minuto. Se der menos de 7 no 5º minuto, repita a cada 5 minutos até 20 minutos de vida.

2

O que não decide

A reanimação começa antes do 1º minuto. Quem guia é a respiração, o tônus e a frequência cardíaca, nunca a nota.

3

Como registrar

Anote o escore junto com os procedimentos feitos em cada minuto (Apgar ampliado). Assim a nota conta a história.

Capurro somático: idade gestacional por 5 sinais físicos

Sinal	Do menos ao mais maduro (pontos)
Textura da pele	muito fina e gelatinosa 0 · fina e lisa 5 · discreta descamação 10 · grossa, descama mãos e pés 15 · grossa, enrugada, marcas profundas 20
Forma da orelha	chata, sem curvatura 0 · borda superior parcialmente encurvada 8 · toda a borda superior 16 · pavilhão todo encurvado 24
Glândula mamária	não palpável 0 · menor que 5 mm 5 · de 5 a 10 mm 10 · maior que 10 mm 15
Aréola	apenas visível 0 · menor que 7,5 mm, lisa 5 · maior, pontiaguda, borda plana 10 · borda elevada 15
Pregas plantares	sem pregas 0 · marcas mal definidas 5 · bem definidas, sulcos no 1/3 anterior 10 · sulcos na metade anterior 15 · em mais da metade 20

Conta: (soma + 204) ÷ 7

A soma mais 204 dá a idade em dias. Dividindo por 7, em semanas. O Ministério da Saúde indica o método para bebês de 29 semanas ou mais.

Alternativa: New Ballard

Junta sinais físicos e neuromusculares e cobre de 20 a 44 semanas. Abaixo de 26 semanas, é mais preciso feito nas primeiras 12 horas.

O fluxo da diretriz 2026

A SBP publicou em 12/06/2026 as novas diretrizes do Programa de Reanimação Neonatal, que substituem as de 2022. Resumo para RN de 34 semanas ou mais:

- Três perguntas ao nascer:** 34 semanas ou mais? Respira ou chora? Tônus em flexão? Se sim, fica em pele a pele e o cordão é clampeado com **60 segundos ou mais**.
- Não respira ou está hipotônico:** estímulo tátil delicado no dorso, por cerca de 15 segundos, antes de clampear. Respirou: clampeie com 60 s ou mais. Não respirou: clampeie (a ordenha do cordão intacto é uma opção) e leve à mesa com calor radiante.
- Passos iniciais em até 30 segundos:** secar, trocar os campos úmidos, touca, pescoço em leve extensão. Aspirar boca e narinas só se houver excesso de secreção.
- Apneia, respiração irregular ou FC abaixo de 100:** VPP com máscara nos primeiros 60 segundos, em **ar ambiente (21%)**. Um profissional ventila, outro coloca os 3 eletrodos do monitor e o oxímetro no pulso radial direito.
- Reavalie em 30 segundos.** A FC é o principal guia. Sem melhora, corrija a técnica (máscara, via aérea, pressão) antes de subir o O2. Considere máscara laríngea ou intubação.
- FC abaixo de 60 após 30 s de VPP por cânula, com boa técnica:** massagem 3:1 com O2 a 100% e reavaliação em 60 s. Persistindo, adrenalina por decisão médica.

Minuto de ouro

O risco de morte ou morbidade sobe 16% a cada 30 segundos de atraso para iniciar a VPP.

VPP e massagem em números

30 a 60 ventilações/min, pressão inspiratória de 20 a 30 cmH2O, PEEP de 5. Massagem no terço inferior do esterno, 1/3 do tórax, 120 eventos/min.

	34 semanas ou mais	Menos de 34 semanas
Temperatura	Sala a 23-25 °C, secar, touca, pele a pele. Alvo axilar de 36,5 a 37,5 °C	Abaixo de 32 sem: mesa com calor radiante, saco plástico sem secar o corpo e touca dupla
O2 para iniciar a VPP	21% (ar ambiente)	60% , novidade de 2026
Ajuste do O2	Pela SpO2 pré-ductal, 20% para mais ou para menos a cada 30 segundos, com blender	
Desconforto com FC de 100 ou mais	Monitorar SpO2, considerar CPAP	CPAP de 5 a 6 cmH2O em máscara com peça T

Minutos de vida	2	3	4	5	10
SpO2 alvo pré-ductal (atualizada em 2026)	65-70%	70-75%	75-80%	80-85%	85-95%

A primeira hora e os cuidados imediatos

A Nota Técnica 124/2026 do Ministério da Saúde chama os primeiros 60 minutos de hora de ouro: clampeamento oportuno, contato pele a pele e amamentação vêm antes da rotina.

1

Pele a pele

Imediato e sem interrupção por pelo menos 1 hora, também na cesárea. Seque o corpo, menos as mãos, e use touca e manta aquecidas.

2

Amamentação

Início na primeira hora, conforme os sinais de prontidão do bebê. É o Passo 4 da Iniciativa Hospital Amigo da Criança.

3

Temperatura

No RN com boa vitalidade, o pele a pele aumenta a temperatura e reduz em 84% o risco de hipoglicemia, segundo a SBP.

Cuidado	Como fazer	Quando
Identificação	Pulseiras na mãe e no RN. O ECA (art. 10) exige impressão plantar e digital do RN e digital da mãe.	O mais cedo possível, sem tirar do pele a pele
Vitamina K	1 mg por via intramuscular, dose única. Se os pais recusarem, há esquema oral de várias doses.	Após a primeira hora
Profilaxia ocular	A Nota Técnica 11/2024 troca o nitrato de prata 1% por iodopovidona 2,5% , eritromicina 0,5% ou tetraciclina 1%. Nitrato só se não houver os outros.	Pode ser feita até 4 horas após o nascimento
Vacina hepatite B	1 dose ao nascer. Mãe HBsAg positiva: vacina e imunoglobulina em músculos diferentes.	Na sala de parto ou nas primeiras 12 horas
Peso, medidas e banho	Antropometria depois do pele a pele. Banho não é recomendado nas primeiras 24 horas.	Após a primeira hora

Rotina não interrompe a hora de ouro. A NT 124/2026 manda adiar pesagem, medidas, vacinas e profilaxias até o fim da primeira hora ou da primeira mamada. Se o bebê precisar de reanimação, ela vem primeiro e o pele a pele começa depois da estabilização.

Atenção: o manual do MS de 2014 ainda descreve o método de Credé com nitrato de prata. Para profilaxia ocular, vale a Nota Técnica 11/2024. Doses e produtos seguem a prescrição e o protocolo da sua maternidade.

Caso aplicado e ficha da sala de parto

CÁLCULO RESOLVIDO

RN a termo (caso fictício): Apgar e Capurro

Ao nascer, não chorava e estava hipotônico. Estímulo no dorso por 15 s: chorou e flexionou. Ficou no pele a pele, cordão clampeado com 60 s

1º minuto: FC 2 + respiração 2 + tônus 1 (alguma flexão) + reflexo 1 (careta) + cor 1 (extremidades roxas) = **Apgar 7**

5º minuto: FC 2 + respiração 2 + tônus 2 + reflexo 2 + cor 1 = **Apgar 9**

Capurro: pele 15 + orelha 16 + mama 10 + aréola 10 + pregas 15 = 66 pontos

$(66 + 204) \div 7 = 270 \div 7 = 38 \text{ semanas e } 4 \text{ dias}$ (270 dias = $38 \times 7 + 4$)

A decisão foi tomada nos primeiros segundos, pela respiração e pelo tônus, antes de existir nota. Extremidades arroxeadas nos primeiros minutos são comuns e explicam por que o 10 é raro.

FERRAMENTA PARA IMPRIMIR

Ficha de avaliação na sala de parto

Mãe	Data e hora		
IG pela DUM ou USG	Peso		

Apgar	1º	5º	10º	15º
Frequência cardíaca				
Respiração				
Tônus muscular				
Irritabilidade reflexa				
Cor				
Total				

Capurro	Opções	Pts
Textura da pele	0 · 5 · 10 · 15 · 20	
Forma da orelha	0 · 8 · 16 · 24	
Glândula mamária	0 · 5 · 10 · 15	
Aréola	0 · 5 · 10 · 15	
Pregas plantares	0 · 5 · 10 · 15 · 20	
(soma + 204) ÷ 7 =		

Cuidado	Horário	Responsável ou observação
☐ Pele a pele iniciado (minuto de vida)		
☐ Clampamento do cordão (segundos)		
☐ Primeira mamada		
☐ Identificação (pulseiras e impressões)		
☐ Vitamina K 1 mg IM		
☐ Profilaxia ocular (produto)		
☐ Vacina hepatite B		
☐ Temperatura axilar na 1ª hora		

Precisou de reanimação? Anote no prontuário cada procedimento com o minuto em que foi feito, ao lado do Apgar.



• FONTES E METODOLOGIA

De onde vêm as informações

Todas as fontes foram consultadas em 04/10/2026. A seleção dos passos, os resumos, o caso fictício e a ficha foram feitos pela ITH a partir dessas fontes. O texto das diretrizes da SBP não foi reproduzido: consulte os documentos completos.

- 01** SBP, Programa Brasileiro de Reanimação Neonatal: Reanimação do RN ≥ 34 semanas em sala de parto, Diretrizes 2026 (12/06/2026)
sbp.com.br/acervo/reanimacao-do-recem-nascido-%E2%89%A534-semanas-em-sala-de-parto-junho-2026
- 02** SBP, Programa Brasileiro de Reanimação Neonatal: Reanimação do RN < 34 semanas em sala de parto, Diretrizes 2026
sbp.com.br/acervo/reanimacao-do-prematureo-34-semanas-em-sala-de-parto-junho-2026
- 03** Ministério da Saúde: Atenção à Saúde do Recém-Nascido, guia para os profissionais, v. 1, 2ª ed., 2014 (Capurro e cuidados de rotina)
bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/atencao_saude_recem_nascido_v1.pdf
- 04** Ballard JL et al. New Ballard Score, expanded to include extremely premature infants. J Pediatr, 1991
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1880657
- 05** Ministério da Saúde: Nota Técnica nº 124/2026-DAHUD/SAES/MS (contato pele a pele e hora de ouro)
gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/notas-tecnicas/2026/nota-tecnica-no-124-2026-dahud-saes-ms.pdf
- 06** Ministério da Saúde: Nota Técnica nº 11/2024-CACRIAD/CGACI/DGCI/SAPS/MS (profilaxia da conjuntivite neonatal)
portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/Nota-Tecnica-no-11-2024-CACRIAD-CGACI-DGCI-SAPS-MS.pdf
- 07** Ministério da Saúde: Diretrizes Nacionais de Assistência ao Parto Normal, 2017 (vitamina K e prazo da profilaxia ocular)
bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diretrizes_nacionais_assistencia_parto_normal.pdf
- 08** Ministério da Saúde: Instrução Normativa do Calendário Nacional de Vacinação 2026 (hepatite B ao nascer)
gov.br/saude/pt-br/vacinacao/publicacoes/instrucao-normativa-que-instrui-o-calendario-nacional-de-vacinacao-2026.pdf
- 09** Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), art. 10
planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm

Ressalvas. As Diretrizes 2026 do PRN-SBP mudaram a SpO2 alvo, a frequência e a pressão da VPP e a oferta inicial de O2 no prematuro: confira se o protocolo da sua maternidade já foi atualizado. Reanimação neonatal exige treinamento prático certificado. Medicações, doses e intubação seguem prescrição médica e protocolo institucional.



• PARA IR ALÉM

Da sala de parto à **UTI neonatal**

Os primeiros minutos decidem muito do que vem depois. A Pós em UTI Neonatal e Pediátrica da ITH treina em simulação realística a ventilação, o PICC e a urgência neopediátrica que a sala de parto às vezes exige.

Pós-graduação em UTI Neonatal e Pediátrica

- ✓ Simulação realística em laboratório
- ✓ PICC, ventilação mecânica e urgência neopediátrica
- ✓ 440h, formato híbrido, turmas em Goiânia e Brasília
- ✓ Diploma reconhecido pelo MEC (ITH, conceito 5)

[Quero conhecer a pós](#)mkt.faculdadeith.com.br/lp/uti-neonatal-pediatria-captura/

Resumo em 30 segundos

60 s

para iniciar a VPP: o minuto de ouro

16%

a mais de risco a cada 30 s de atraso na VPP

60%

de O2 para iniciar a VPP abaixo de 34 semanas

1 hora

mínima de pele a pele no RN com boa vitalidade